



République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Université des sciences de la santé d' Alger
Faculté de Médecine Dentaire
Service de Parodontologie (Chef de service Pr. M.Meddad)

Formation de la jonction gingivo-dentaire

Présenté par : Dr. MESMOUS
Année universitaire : 2025/2026.

Plan du Cours

1. Introduction : Le Parodonte et la JGD
2. Définition et Composition de la JGD
3. Formation de l'Attache Épithéliale (Étapes 1-4)
4. Formation de l'Attache Conjonctive
5. Rôle Essentiel de la JGD
6. Conclusion

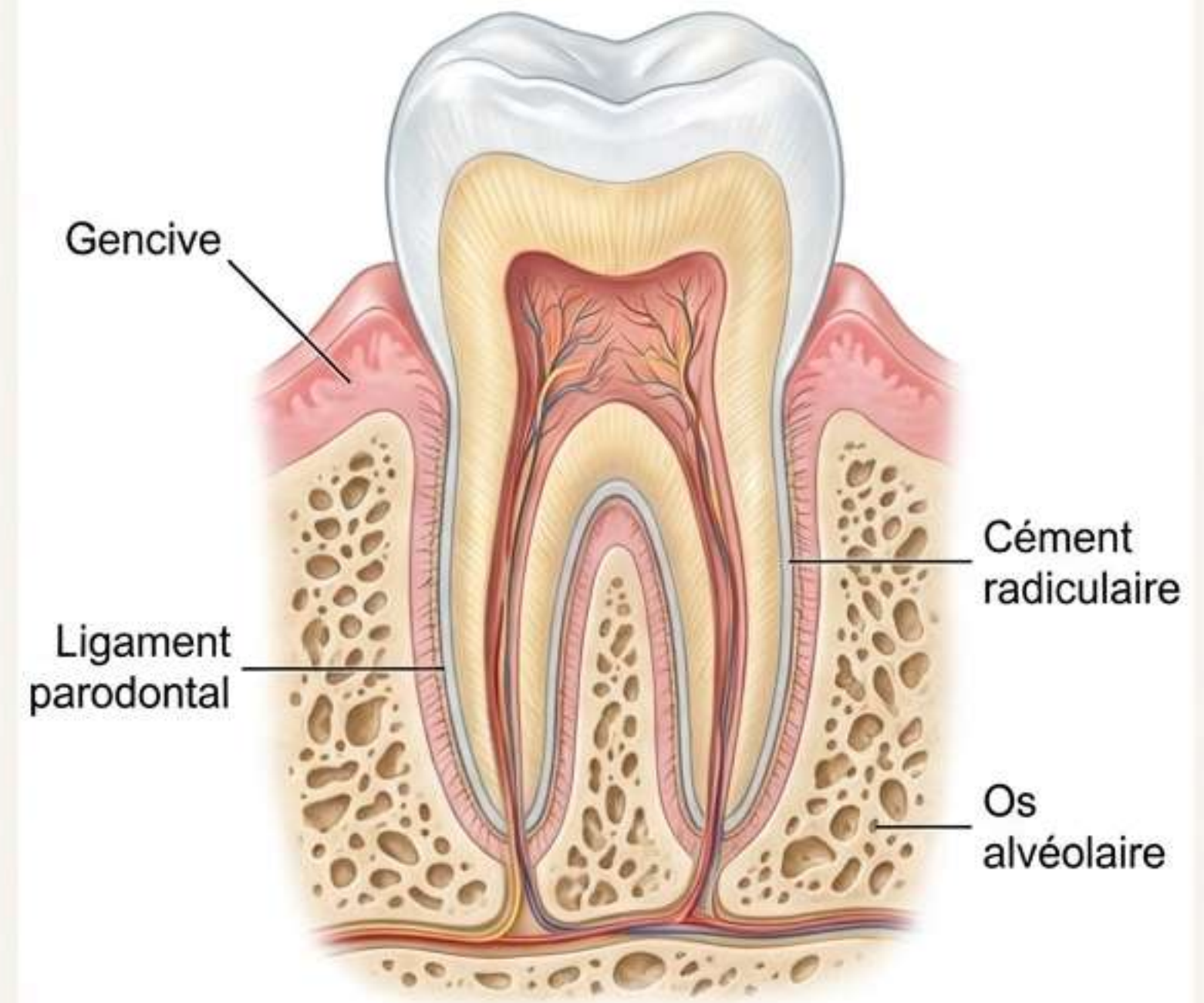


Le Contexte : Au Cœur du Soutien de la Dent, le Parodonte

Le parodonte (péri = autour, odontos = dent) comprend les tissus suivants : la gencive, le ligament parodontal, le cément radiculaire et l'os alvéolaire.

La gencive adhère à la surface de la dent grâce à un système d'attache.

L'épithélium jonctionnel (EJ) joue un rôle essentiel dans le maintien de la santé parodontale : il assure l'attache épithéliale et crée ainsi la connexion solide entre les tissus mous et la surface de la dent.



La JGD : Barrière Gardienne du Parodonte

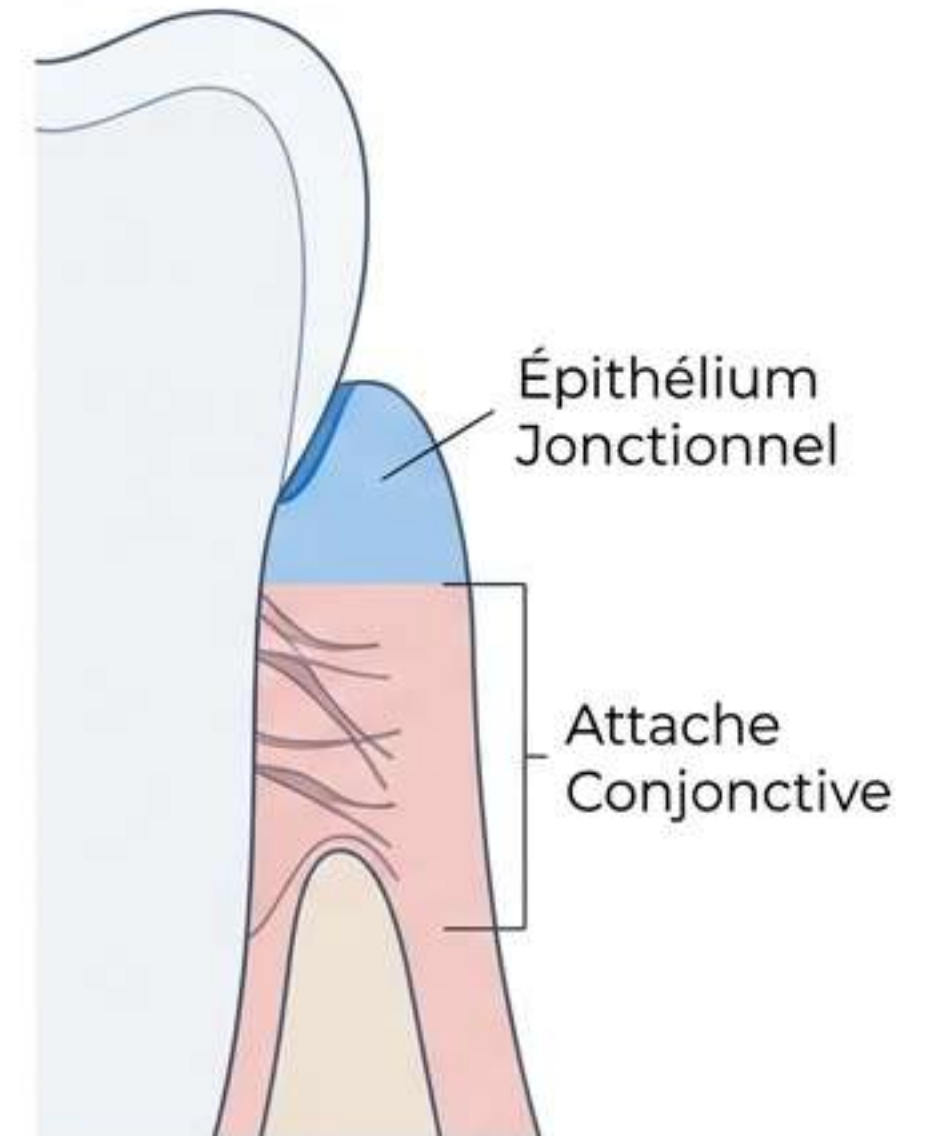
Définition

La jonction gingivo-dentaire (JGD) est un ensemble biologique qui sépare le milieu intérieur de la cavité buccale.

C'est une barrière physique et physiologique dont la cohésion conditionne l'intégrité des structures parodontales sous jacentes [Q2].

Composition

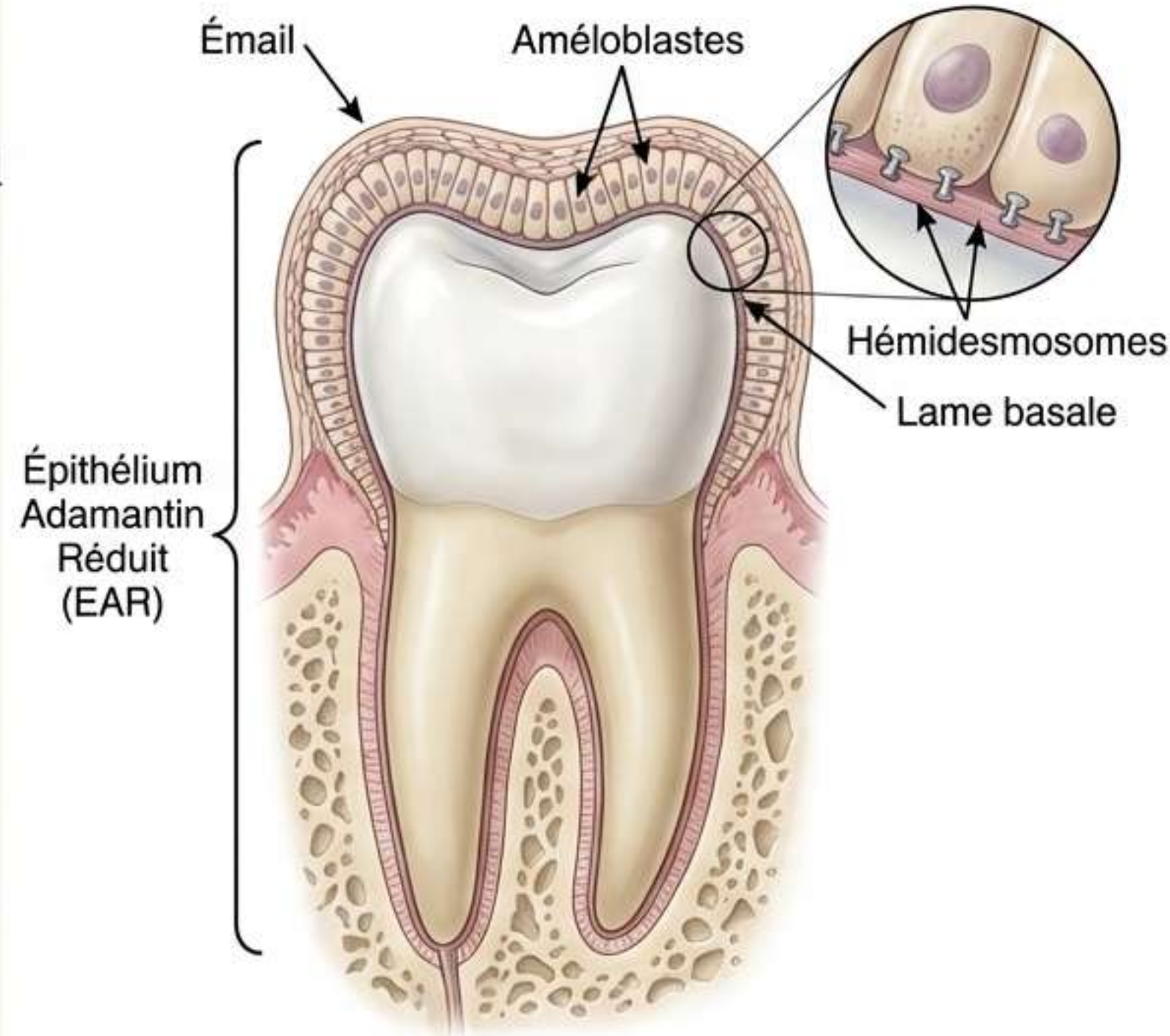
1. L'épithélium jonctionnel (ou attache épithéliale) [Q1, Q2, Q9], qui relie la gencive à la dent.
2. Une attache conjonctive [Q1, Q3] constituée des fibres gingivo-dentaires.



Phase 1 : Avant l'Éruption - La Préparation

Lorsque l'émail est complètement formé, les cellules productrices d'émail (les **améloblastes** [Q4]) diminuent de hauteur et produisent une **lame basale**.

Les améloblastes forment, avec les restes des autres cellules de l'organe dentaire, l'**épithélium adamantin réduit (EAR)**.

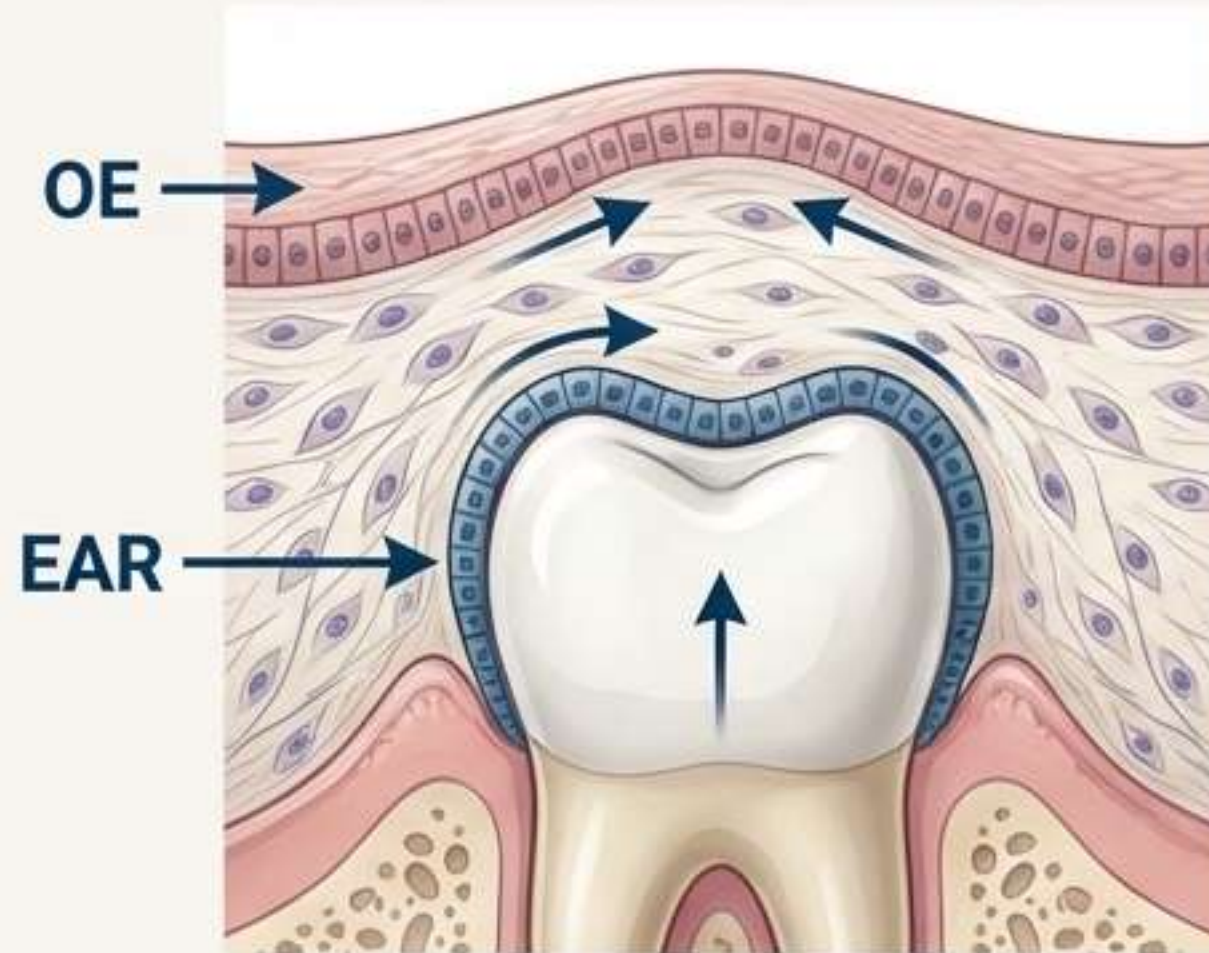


L'EAR entoure la couronne de la dent depuis la minéralisation complète de l'émail jusqu'au début de l'éruption [Q5].

Le contact entre la lame basale et les cellules épithéliales est maintenu par des **hémidesmosomes** [Q6, Q9].

Phase 2 : L'Approche et la Fusion des Épithéliums

Approche



Fusion



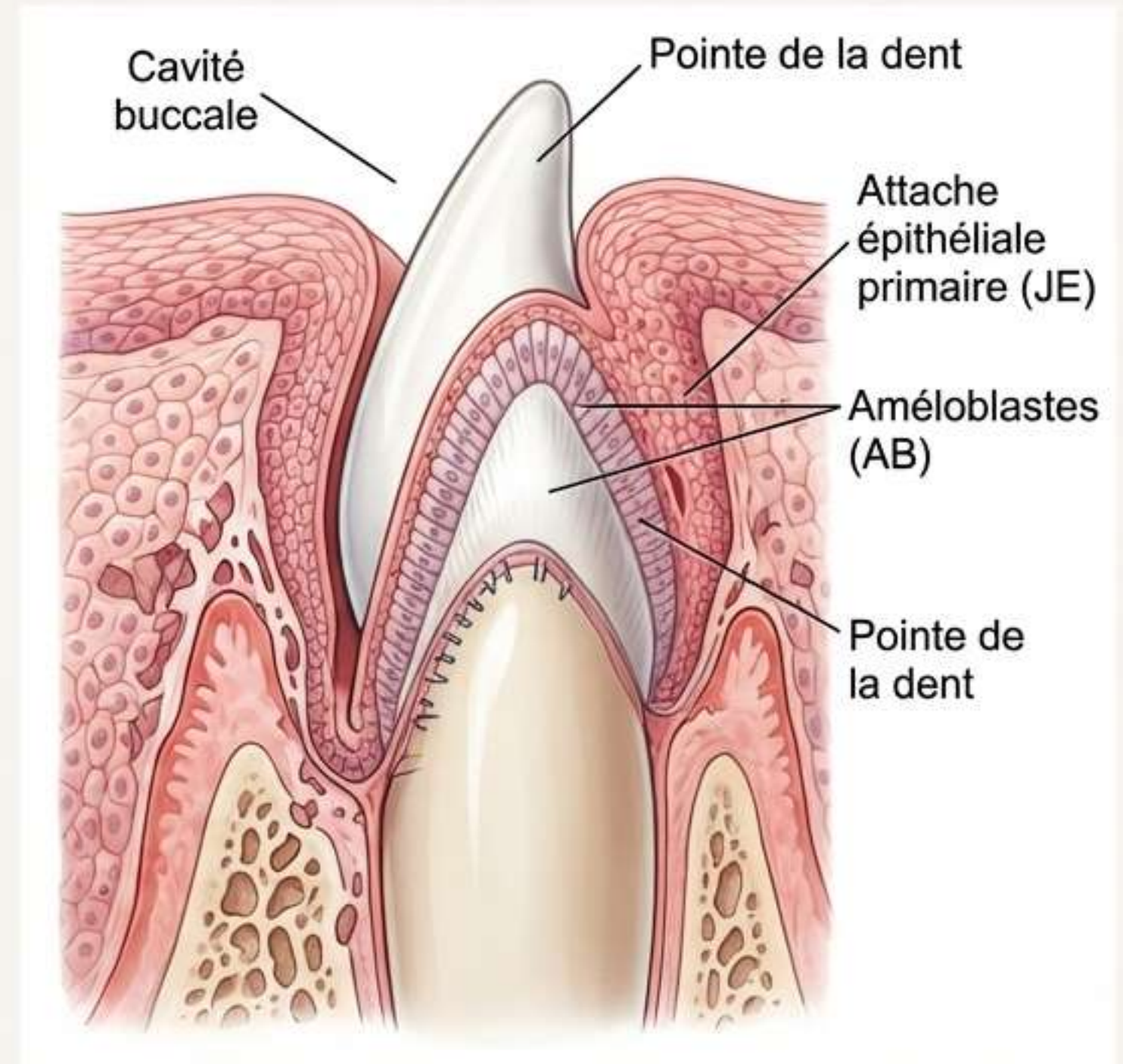
- À mesure que la dent approche de l'épithélium buccal, les cellules de l'EAR et de l'épithélium buccal présentent une **activité mitotique accrue**.
 - Les deux épithéliums migrent et fusionnent pour former une masse épithéliale unifiée.
- ** Point Clé:** Cette fusion permet l'éruption de la dent sans saignement.

Phase 3 : L'Émergence et la Création de l'Attache Primaire

- Au moment de l'éruption [Q3, Q7], le tissu conjonctif se fragmente.
- L'EAR et l'épithélium buccal fusionnent.
- Quand le sommet de la dent émerge, les cellules de l'épithélium buccal migrent apicalement, formant ainsi l'attache épithéliale primaire.

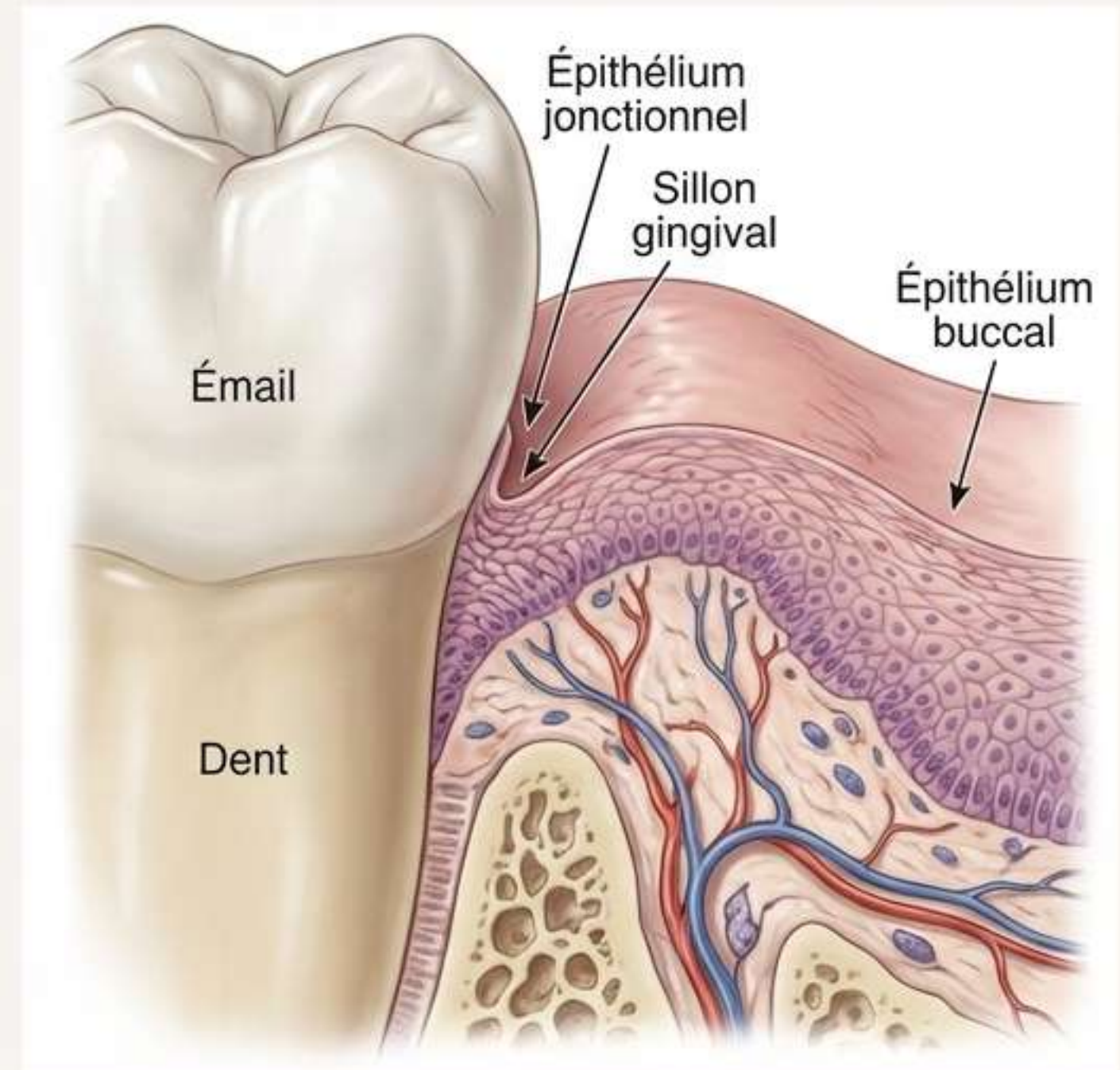
Composition de l'Attache Primaire

- Lame basale interne
- Hémidesmosomes
- L'organe adamantin réduit (EAR)
- Lame basale externe



Phase 4 : La Maturation vers l'Attache Épithéliale Secondaire

- Au cours des dernières phases de l'éruption, les cellules de l'EAR sont progressivement remplacées par l'épithélium jonctionnel.
- Les améloblastes se transforment en cellules malpighiennes, en conservant leur attache à la surface de l'émail [Q6].
- **Origine Double:** L'attache épithéliale secondaire définitive est formée de cellules issues à la fois de l'épithélium adamantin réduit et de l'épithélium de la muqueuse buccale [Q8].

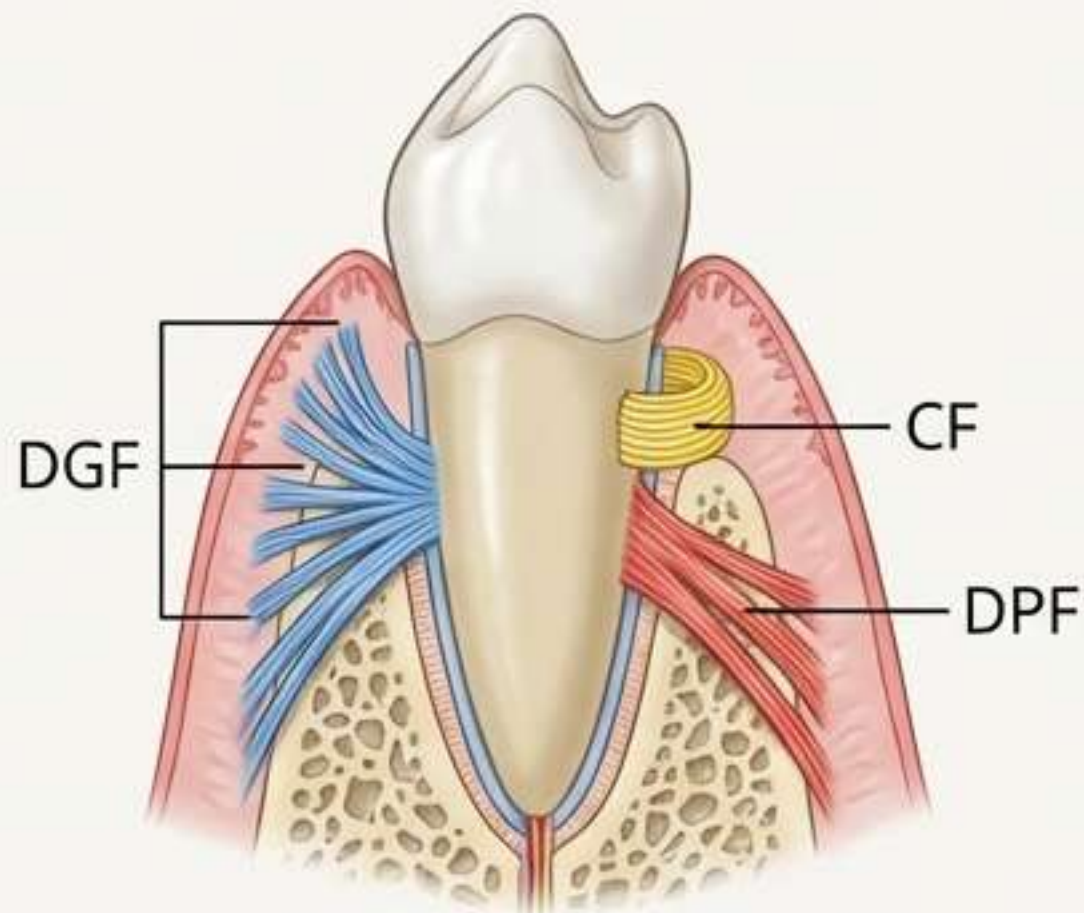


L'Autre Moitié de la JGD : L'Ancrage par l'Attache Conjonctive

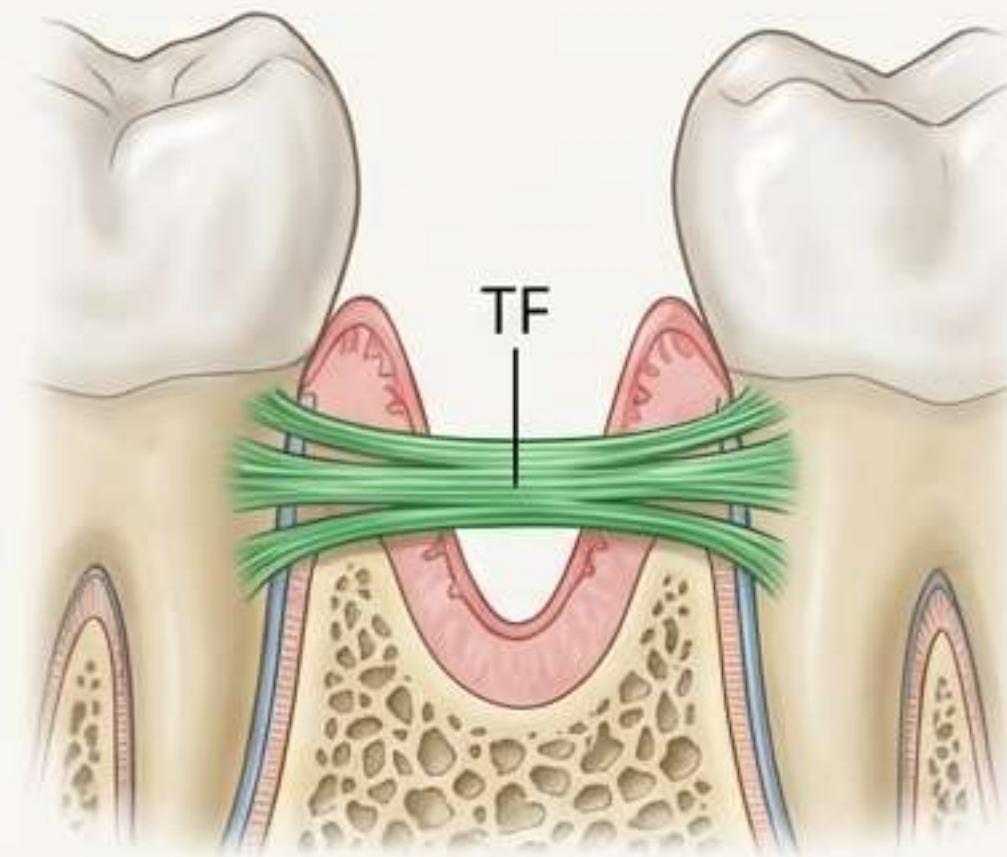
La formation des fibres gingivales se fait **au cours de la formation du cément radiculaire.**

Ces groupes de fibres gingivales assurent la fixation de la gencive sur le **collet des dents [Q10]**.

Principaux groupes : fibres dento-gingivales (DGF), fibres circulaires (CF), fibres dento-périostées (DPF), fibres trans-septales (TF).



Coupe vestibulo-linguale



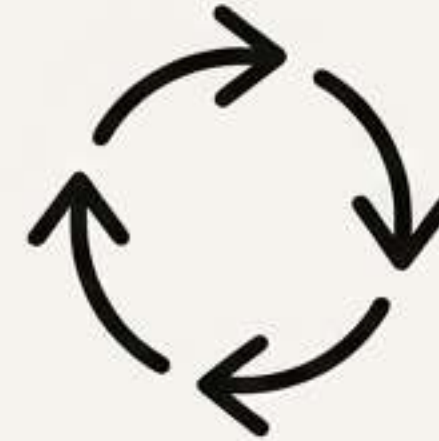
Coupe mésio-distale

Les 4 Missions Clés de la Jonction Gingivo-Dentaire

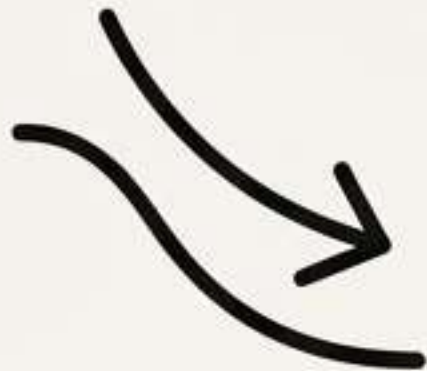
La JGD joue un rôle essentiel dans le maintien de la santé parodontale par :



L'adhésion : Assurée par la juxtaposition et l'interrelation des différentes structures de l'épithélium de jonction.



Le renouvellement : L'attache épithéliale subit un renouvellement permanent de ses cellules qui desquament en superficie.

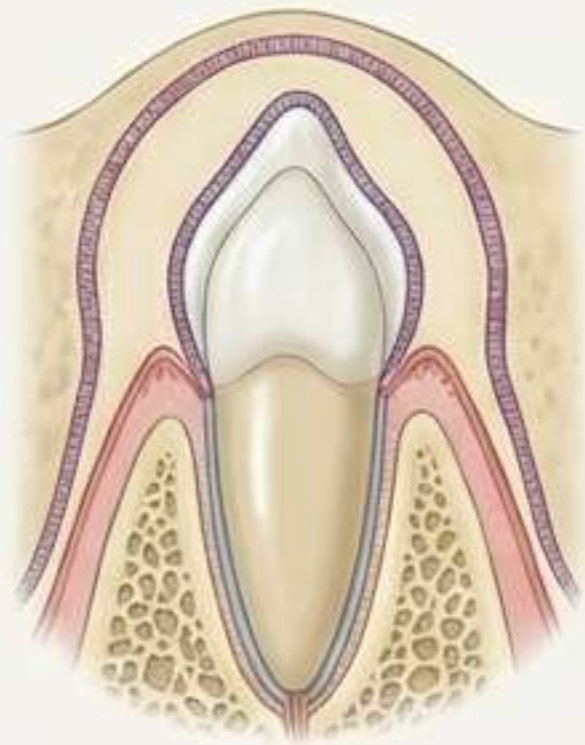


La dynamique : L'attache n'est pas statique ; elle glisse le long de l'émail au fur et à mesure que la couronne émerge (éruption passive).

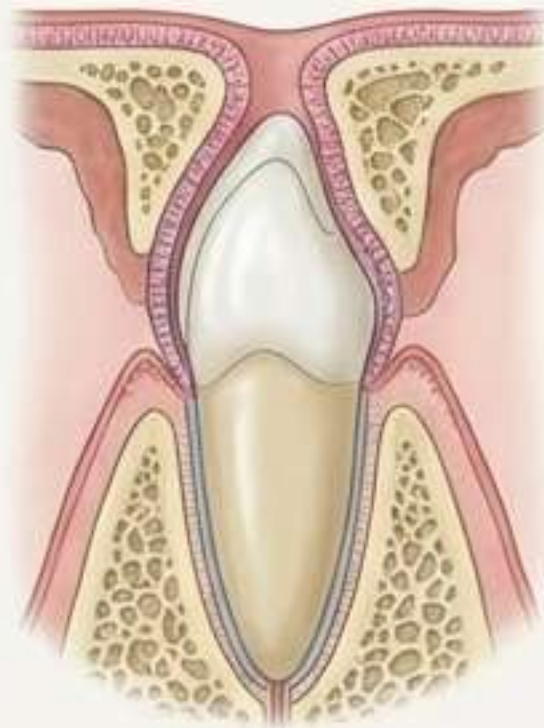


Le potentiel de défense : La perméabilité permet le passage des cellules phagocytaires, et le fluide gingival transporte les facteurs de défense.

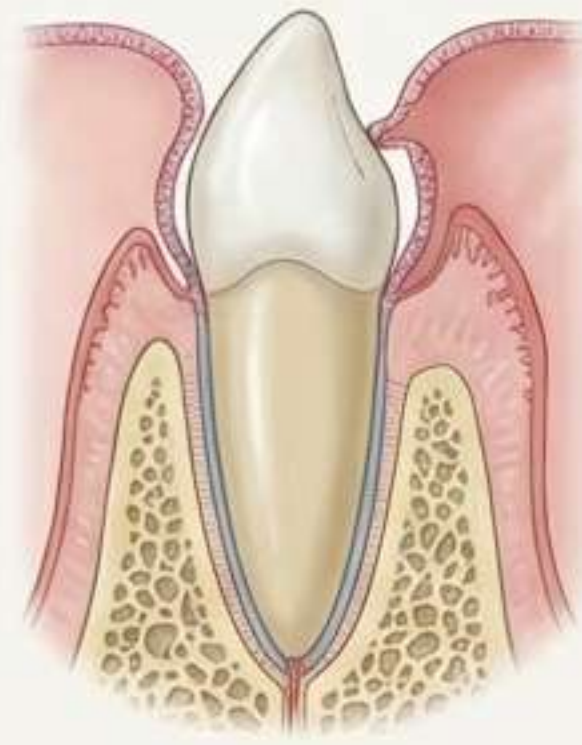
Le Processus de Formation en un Coup d'Œil



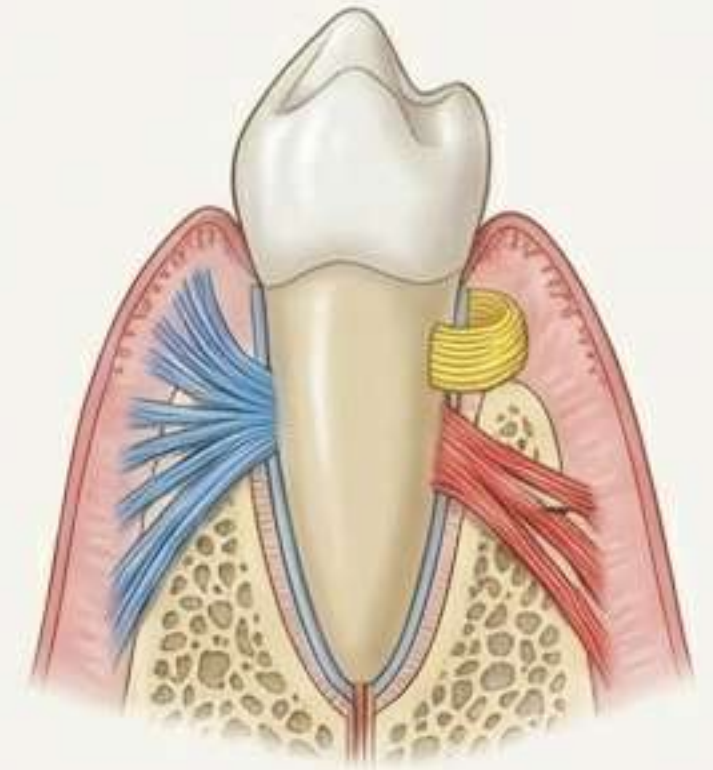
1. Préparation



2. Fusion



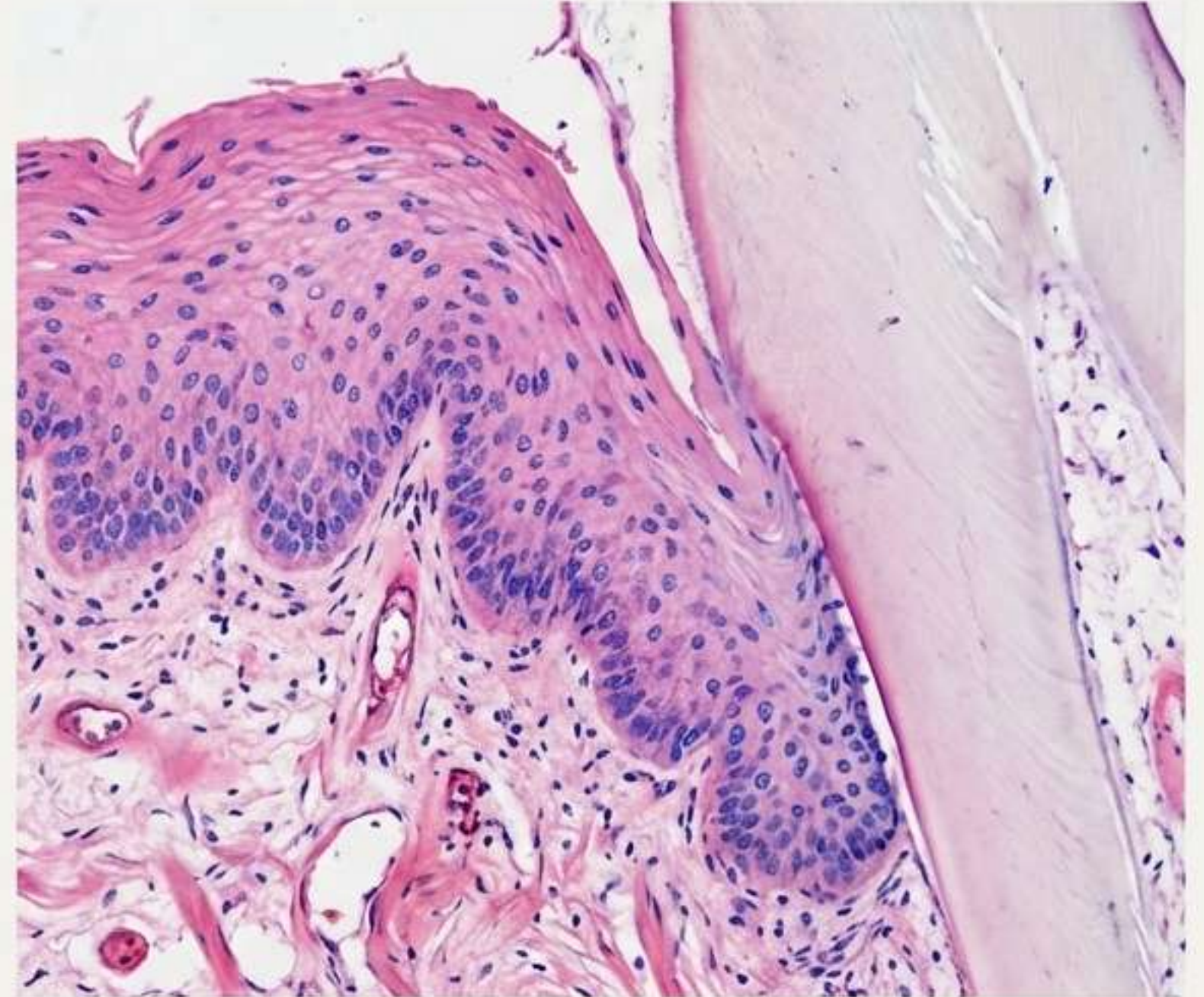
3. Émergence



4. Maturation

Ce qu'il Faut Absolument Retenir

- La formation de la jonction gingivo-dentaire est une étape essentielle qui résulte d'un processus coordonné entre l'éruption dentaire, la migration épithéliale et la mise en place des attaches épithélio-conjonctives.
- Comprendre ces mécanismes permet non seulement d'expliquer la physiologie parodontale, mais aussi de mieux interpréter les altérations observées dans les maladies parodontales.



Références Bibliographiques

1. Benoit R, Pellerin C. Introduction à la biologie du développement: Embryologie dentaire. E.M.C-stomatologie 22005-B-10
2. Rateitschak KH, Wolf HF. Color Atlas of Dental Medicine, Periodontology. 3rd Edition. 2005.
3. Lang NP, et al. Lindhe's Clinical Periodontology and Implant Dentistry. Vol.1. 7th Edition. Wiley-Blackwell;2021.